一度：　8点 8点 8点 8点 8点
二度I型：　6点 8点 9点 x 6点 8点 9点 x
二度II型：8点 × × 8点 × x
三度：各玩各的

本来6点回家

2.心电图

（1）一度房室阻滞

①QRS 波不脱落，QRS 波形态多正常

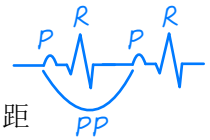
②**PR 间期恒定延长＞0.2s**（1 大格），因此 $S_1$ 强度**恒定减弱**

PR间期越↑→心室舒张充血↑→二尖瓣位置越高,关回去路程短→S1↓

（2）二度I型房室阻滞（文氏阻滞）

①**PR 间期进行性延长**，直到出现**一次 QRS 波脱落**（P 波下传受阻），受阻 P 波前的 PR 间期延长，因此 $S_1$ 强度**逐渐减弱和心搏脱落**

P波正常出现(窦房结正常)→PP间距是正常的




RR=PP+(本次PR-上次PR)=PP+PR的增量（正常）

②**RR 间距进行性缩短**（RR 间距=PP 间距+PR 的增量，PR 增量减小）

③包含受阻 P 波在内（脱落 QRS 波前后）的 RR 间距＜2 倍正常 PP 间距

④最常见的房室传导比例为 **3:2 或 5:4**（五年高考三年模拟）只有一次QRS波脱落

⑤多数阻滞部位在房室结：QRS 波形态多**正常**

本来6点回家
6点 x x 6点 x x 6点 x x
8点 x x 8点 x x 8点 x x

（3）二度II型房室阻滞

“冷不丁脱落”

①**PR 间期基本恒定**（恒定正常或恒定延长），**部分 P 波后无 QRS 波**，因此 $S_1$ 强度**基本恒定伴间歇性心搏脱落**

②最常见的房室传导比例为 3:1 或 4:1，因此多为高度房室阻滞（连续 2 个及以上的 P 波不能下传至心室的二度房室阻滞）

③阻滞部位在房室结者 QRS 波形态多正常；阻滞部位在希氏束-浦肯野纤维者 QRS 波宽大畸形

房颤患者心律变规律,心室率很慢,且有强心苷用药史,要警惕强心苷中毒

（4）三度房室阻滞/完全性房室阻滞

①如**强心苷中毒**、高钾血症、急性**下壁**心梗（下水道堵了）、**急性心肌炎**这些原因所导致的三度房室阻滞上临时起搏器

②房室分离：PR 间期不固定，因此 $S_1$ 强度**变化不定可呈大炮音**（响亮亢进的 $S_1$）三大炮

③心房率快于心室率

心房收缩后心室立刻收缩(正常存在房室延搁所以不会出现这种情况),此时心室血很少,二尖瓣位置很低→S1非常强

④阻滞部位在房室结者一般心室率 **40-60** 次/分（**交界性逸搏心律**）、QRS 波形态**正常**、心律**稳定**；阻滞部位在希氏束-浦肯野纤维者一般心室率＜**40** 次/分（**室性逸搏心律**）、QRS 波**宽大畸形**、心律**不稳定**

迷走神经在房室结密度最高,受到迷走神经的调控就会让心律稳定,阻滞部位很低时没有迷走神经调控,心律容易不稳定

小结：爱上一个不回家的人 ttsx

| 房室阻滞 | 一度 | 二度I型 | 二度II型 | 三度各玩各的 |
|---|---|---|---|---|
| QRS 波脱落 | 不 | 有 | | |
| QRS 波形态 | 多正常 | | 阻滞在希氏束或以上：多正常<br>阻滞在希氏束以下：宽大畸形 不走寻常路 | |
| **PR 间期** | 恒定延长＞0.2s | 进行性延长 | 基本恒定 | 不固定 |
| **$S_1$ 强度** | 恒定减弱 | 逐渐减弱和心搏脱落 | 基本恒定伴间歇性心搏脱落 | 变化不定可呈大炮音 |

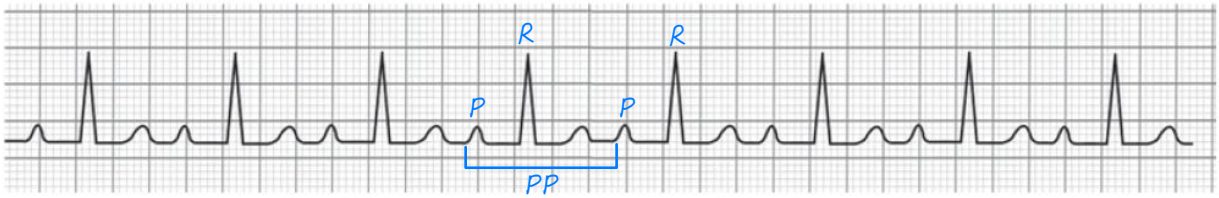



图 5-1-79　一度房室传导阻滞

RR=PP+(本次PR-上次PR) 只要PR固定,RR=PP
一度房室阻滞:PR固定(恒定延长),RR=PP
二度I型:PR间期进行性延长